EBM 3%問題

エビデンスって信頼していいの？ — SRMAの「3%問題」

参考文献

2026-05-27 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

今日の出発点

- 「論文がたくさんあるから信頼できる」は本当？
- 世界では1日約80本（2019年時点）の系統的レビューが発表されている
- 方法論的に健全で臨床的に有益なのは **約3%** という見積もりがある

約80本のうち、約3%

1日換算（PubMed収載のSRMA）

約80本

2019年 約29,000本（推計）
2000年は約1,400本

→

方法論的に健全で臨床的に有益

約3%

見積もり（Ioannidis 2016）
≒1日2〜3本（概算）

系統的レビュー全体に対する約3%の幅（模式）



0　　100%

出典: Hoffmann 2021（本数）、Ioannidis 2016（3%）
2026年の編集記事（Rattan 2026）も両者を引用

PART 1

系統的レビューって何?

系統的レビュー（SRMA）とは

- 同じテーマの複数の研究をまとめて分析した論文
- 「エビデンスのトップ」とされてきた
- ガイドラインの根拠になることが多い

→ でも今、その「トップ」に品質問題が起きている

なぜ量産されているのか

- 研究者は「論文を出すこと」で評価される
- 系統的レビューは比較的速く作れる
- 結果: 質より量になってしまっている

PART 2

何が問題？

PART 2・何が問題?

質の低いSRMAが起こすこと

1. 間違った情報がガイドラインに入る
2. 医療スタッフが誤った根拠を信じてしまう
3. 患者さんのケアに影響が出る

「エビデンスに基づく医療」が逆効果になるリスク

PART 2・何が問題?

私たちにできること

場面	行動
論文を読む前	「この研究はどれだけ信頼できるか」と一問
会議・勉強会で	「根拠は何か」を確認する習慣
ガイドラインを使う時	「A推奨の根拠SRMAは質が高いか」を問う

PART 3

職種別アクション

医師・研修医

- AMSTAR-2チェックリストを使う（5分）
- Forest plot の I^2（ばらつきの目安）をざっと見る
- 「この推奨、どのSRMAが根拠？」と一歩踏み込む

看護師・コメディカル

- 「この手順はなぜ？」の問いを大切にする
- エビデンスの「強さ」より「質」を意識する
- チームで「根拠は？」と聞き合える文化をつくる

薬剤師

- 薬の適応・用量根拠のSRMAを時々見直す
- 出版バイアス（悪い結果が出にくい構造）を知っておく
- 患者説明に使うエビデンスの質を一段チェックする

PART 4

まとめ

PART 4・まとめ

今日の3つのポイント

1. 系統的レビューでも **質に大きな差** がある
2. 信頼できて臨床に有益なのは**約3%**という見積もりがある
3. 「論文があるから正しい」ではなく**「その論文の質は?」**が問い

持ち帰りのひと言

「エビデンスを信じることと、エビデンスを疑うことは矛盾しない」

品質を確認しながら使うのが、本当のEBMの姿

PART 4・まとめ

ディスカッション

- 日頃の業務で「これ根拠あるの？」と思ったことはありますか？
- チームで「エビデンスの質」を話せる環境はありますか？